

PLAN DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EL TAMIZAJE DE CÁNCER DE ESTÓMAGO Y COLORRECTAL (2025 – 2029)

Centro Nacional de Detección
Temprana de Cáncer Gastrointestinal

Noviembre, 2025





ANTECEDENTES



1995

Creación del CDTC como programa nacional Convenio CCSS-UCR-JICA



2005

Por acuerdo de JD el CDTC pasa a ser un servicio del HMP



2017

Aprobación oficial del proyecto de Tamizaje de Cáncer Colorrectal



2024

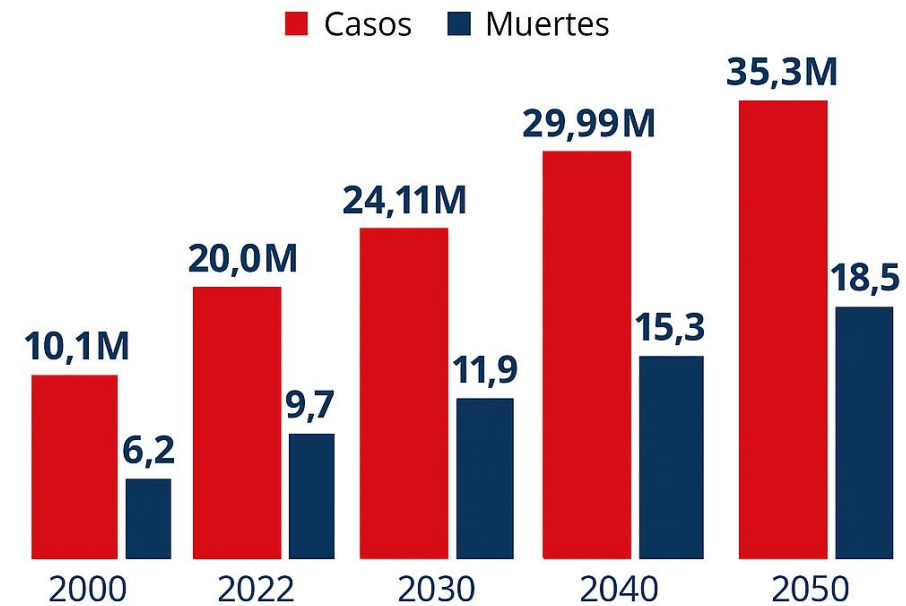
JD aprueba oficialmente la conformación del CNDTCG y se crea la UP 2806



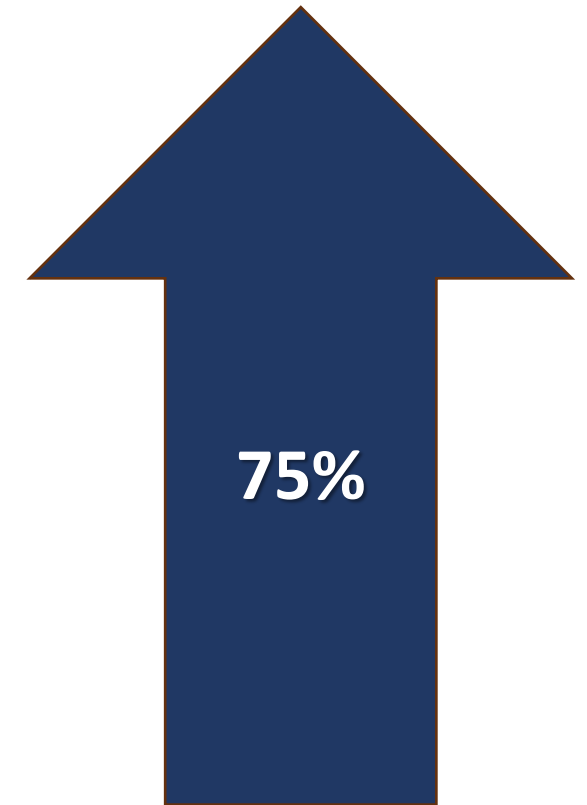
CANCER PROBLEMA GLOBAL

La Carga Global del Cáncer Sigue Creciendo

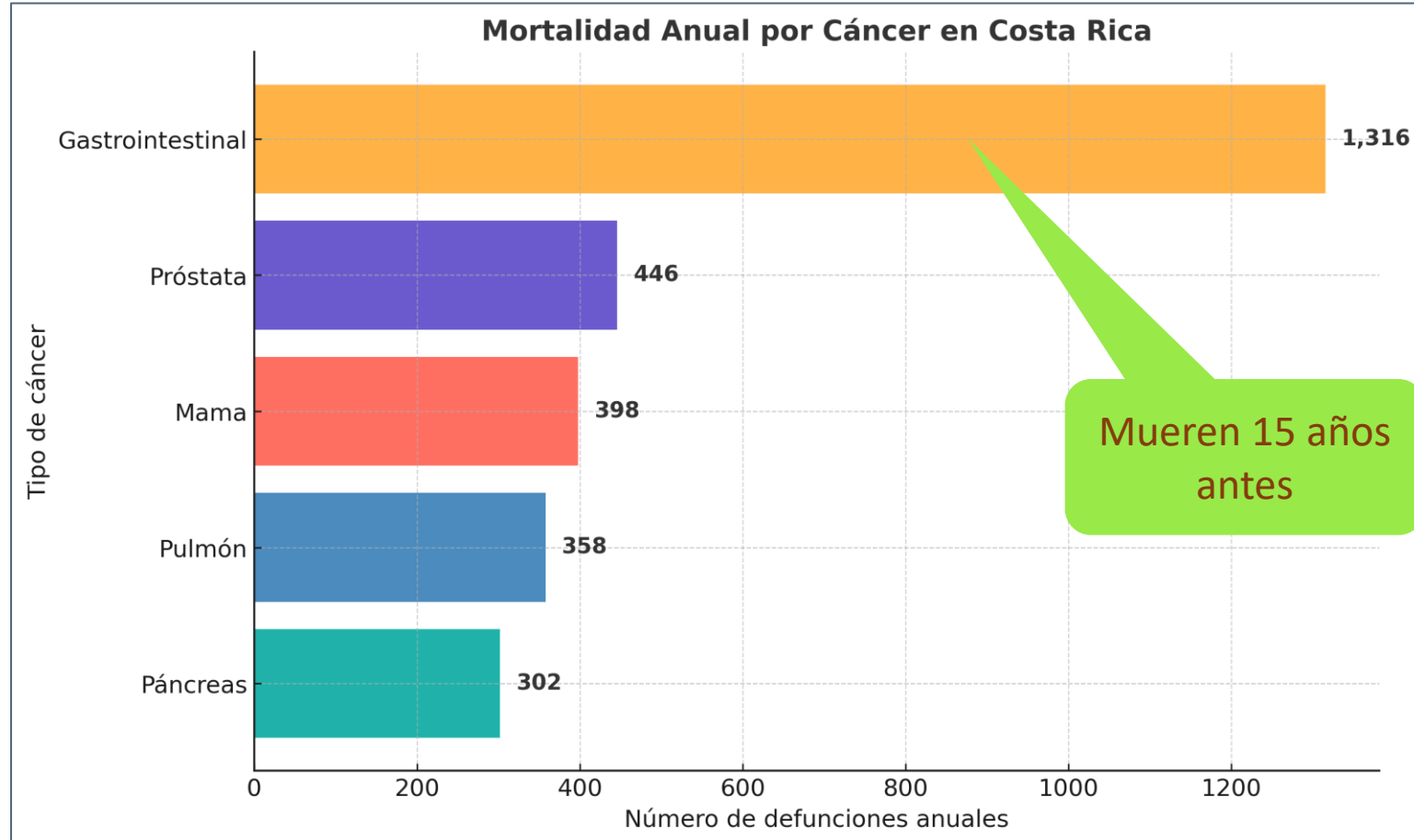
Número estimado de nuevos casos y muertes por cáncer al año, a nivel mundial



Fuente: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
Publicación: *The Lancet*, 2025

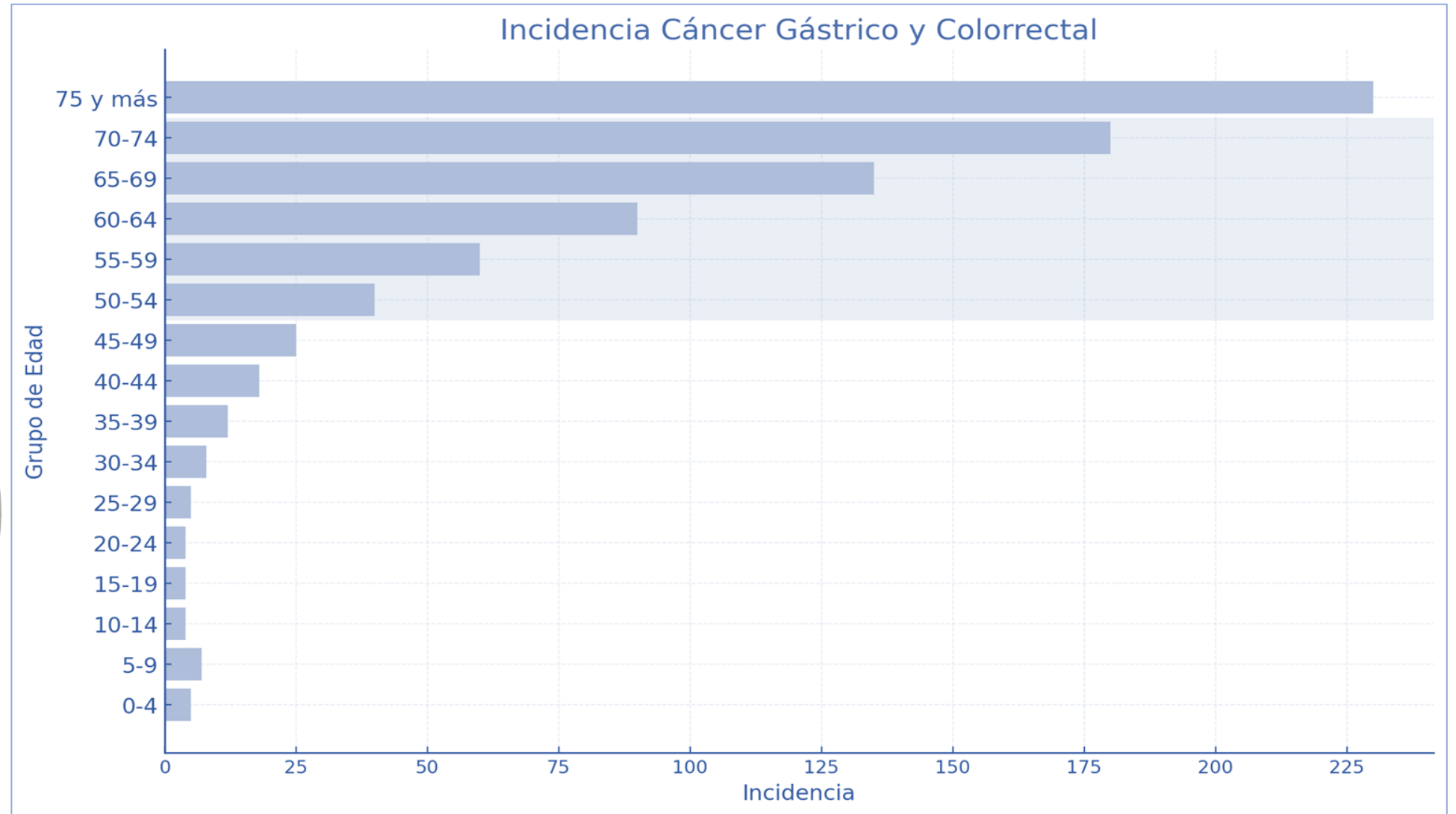


JUSTIFICACIÓN



Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo 2017-2022

JUSTIFICACIÓN

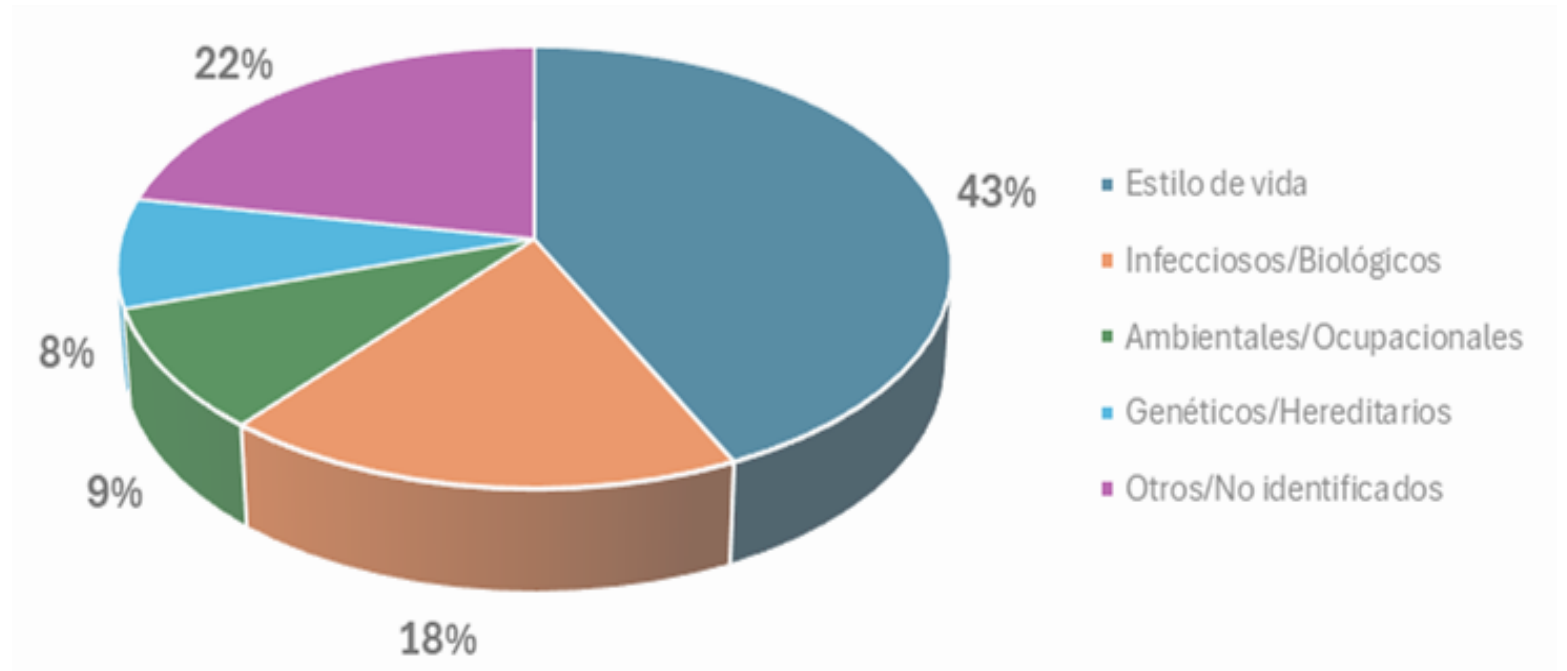
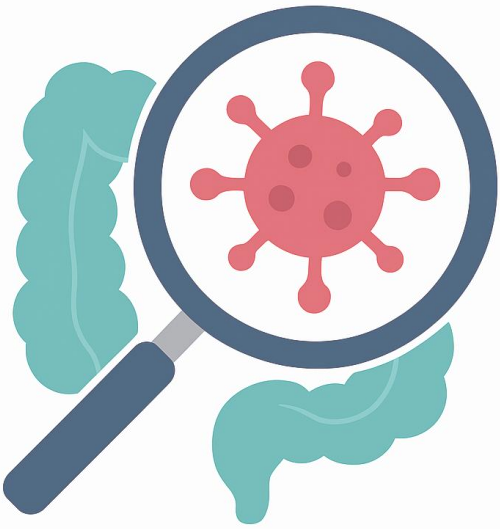


Fuente: Datos del Registro Nacional de Tumores



POBLACIÓN DE RIESGO

¿Por qué tamizar?



Fuente: International Agency for Research on Cancer (IARC). (2020). World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention.



OBJETIVO GENERAL

Implementar el plan de abordaje integral para el tamizaje de cáncer de estómago y colorrectal, desde la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y **SEGUIMIENTO** a la persona usuaria, con el fin de reducir la creciente incidencia y mortalidad asociada a estos tipos de cáncer en Costa Rica





CAMBIO DE PARADIGMA

Paradigma actual



Paciente con síntomas gastrointestinales



Cita en EBAIS/Emergencias



Endoscopia (Lista de Espera)



Biopsia



Diagnóstico de cáncer



Cirugía



Estadio



Quimio/Radio terapia



Control

Paradigma propuesto



Población objetivo identificada

- Zona geográfica
- Incidencia
- Edad



Personas sanas



Campaña de tamizaje



Prueba de tamizaje cada dos años



Endoscopia a personas con pruebas alteradas



Detección de lesiones premalignas/malignas en etapas tempranas

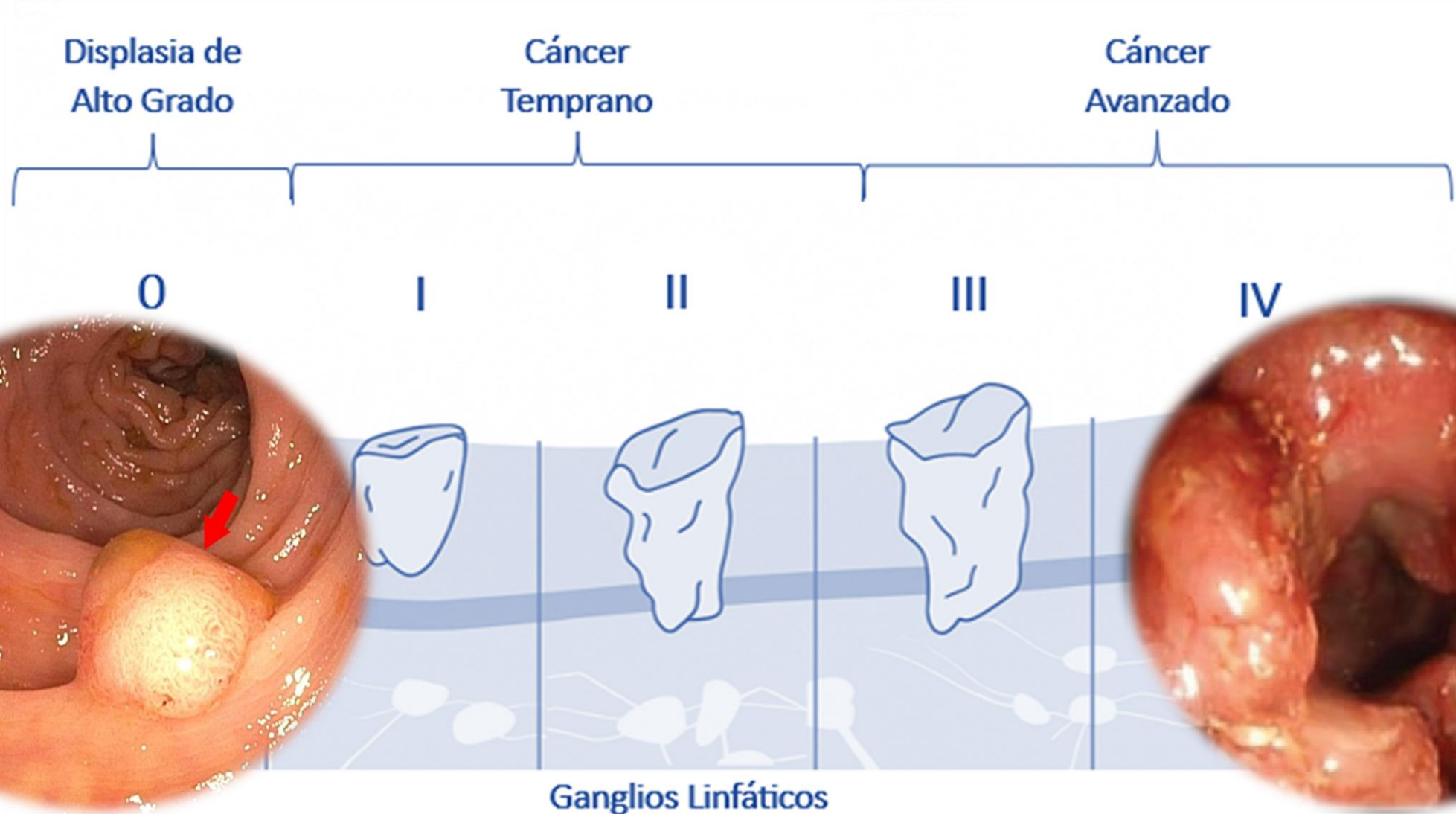


Procedimiento mínimamente invasivo



Control

LA ENFERMEDAD

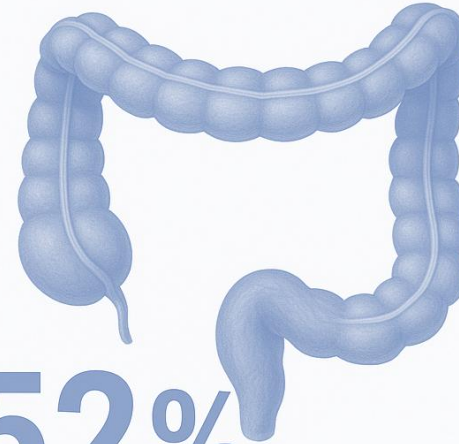


CÁNCER
GÁSTRICO



30%

CÁNCER
COLORRECTAL



52%

Nota: En el caso del cáncer colorrectal se incluye la displasia de alto grado



IMPACTO ECONOMICO

Los cánceres detectados en etapas más tempranas generalmente **cuestan menos de tratar**. Esto ha sido demostrado en **Inglaterra** para los cánceres de mama, colon y recto tratados con resección, radioterapia o terapia sistémica contra el cáncer.

RBC

ARTÍCULO COMPLETO

Revista Británica del Cáncer (2016) 114, 1286–1292 | doi: 10.1038/bjc.71

Keywords: costes; hospital; datos basados en población

Costo de la atención a pacientes con cáncer en Inglaterra: evidencia basada en datos a nivel poblacional

Mauro Laudicella^{1,1}, Brendan Walsh¹, Elaine Burns² Peter C Smith³

¹Escuela de Ciencias de la Salud, City University London, Londres EC1V 0HB, o; Londres EC1V 0HB, Reino Unido

²Departamento de Cirugía y Cáncer, Imperial College London, St Mary's Campus, London W2 1NY, Reino Unido

³Escuela de Negocios, Imperial College London, Tanaka Building, South Kensington Campus, Londres SW7 2AZ, Reino Unido

Costo de la atención a pacientes con cáncer en Inglaterra

Tabla 3. Costos medios por incidencia *Minimos fos costas menoss de tratar.*

	Edad 18–64		Edad ≥65			
	Estadios 1–2	Diferencia	Stages 1–	3–4	Diferencia	
Colorectal(2010 £)						
3 Años pre	205	8	454	414	40	
2 Years pre	257	10	453	491	40	
1 Year	998	– 46	1802	1714	88	
2 Year	14 911	– 4276	14196	15 411	– 1 215	
2 Years	3 656	– 2761	3619	3143	– 1524	
3 Years	3069	– 1380	3034	4065	– 1524	
4 Years	2417	– 1252	2600	3273	– 1573	
5 Years	2195	– 481	2632	3089	– 457	
6 Years	2196	– 995	2632	2954	– 300	
7 Years	1566	– 549	2632	2671	416	
8 Years	1472	– 150	2671	2523	148	
9 Years	1323	– 429	3887	2054	429	
Total (9 Años)	33 728	46 306	38 876	43 170	4 294	

Laudicella, M. et al (2016). British Journal of Cancer, 114(11), 1286–1292.



IMPACTO ECONOMICO

Displasia de Alto
Grado

Temprano

Avanzado



-

¢6,183,369

¢26,516,791



¢1,422,337

¢3,890,815

¢43,158,957

Fuente: Centro de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal



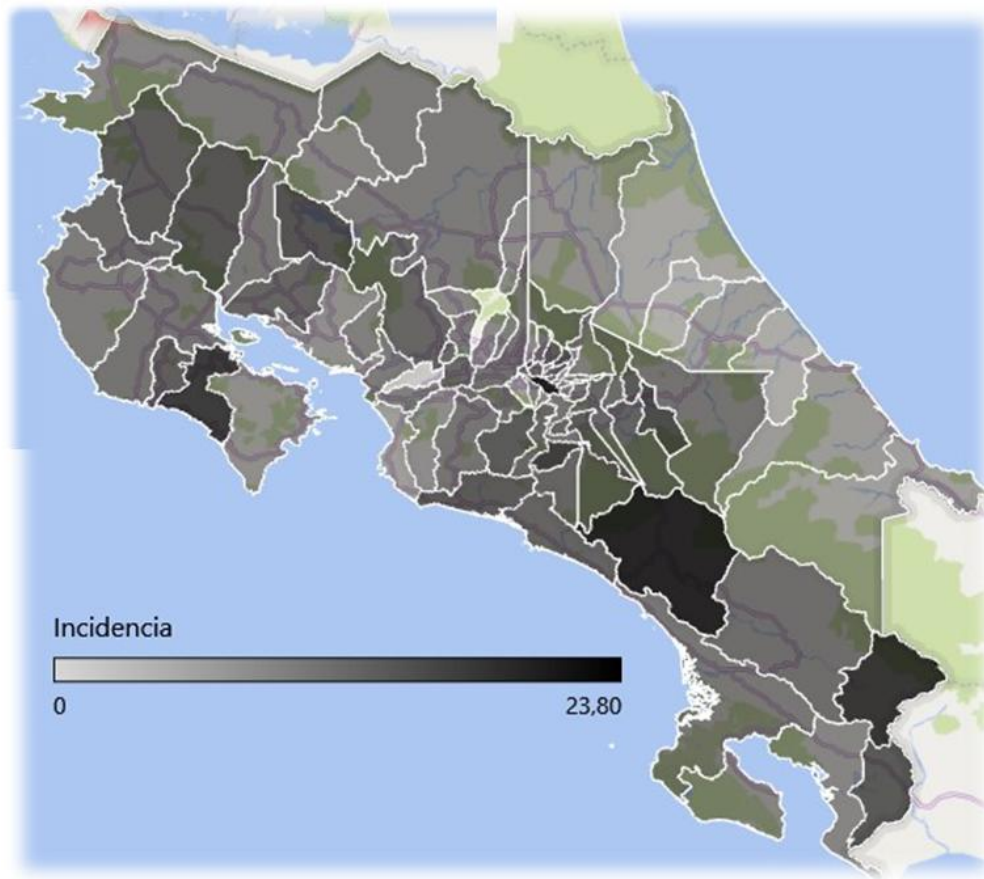
IMPACTO ECONOMICO Y COSTOS ASOCIADOS

Costos Tangibles: son los más evidentes y se relacionan con la detección y los tratamientos.

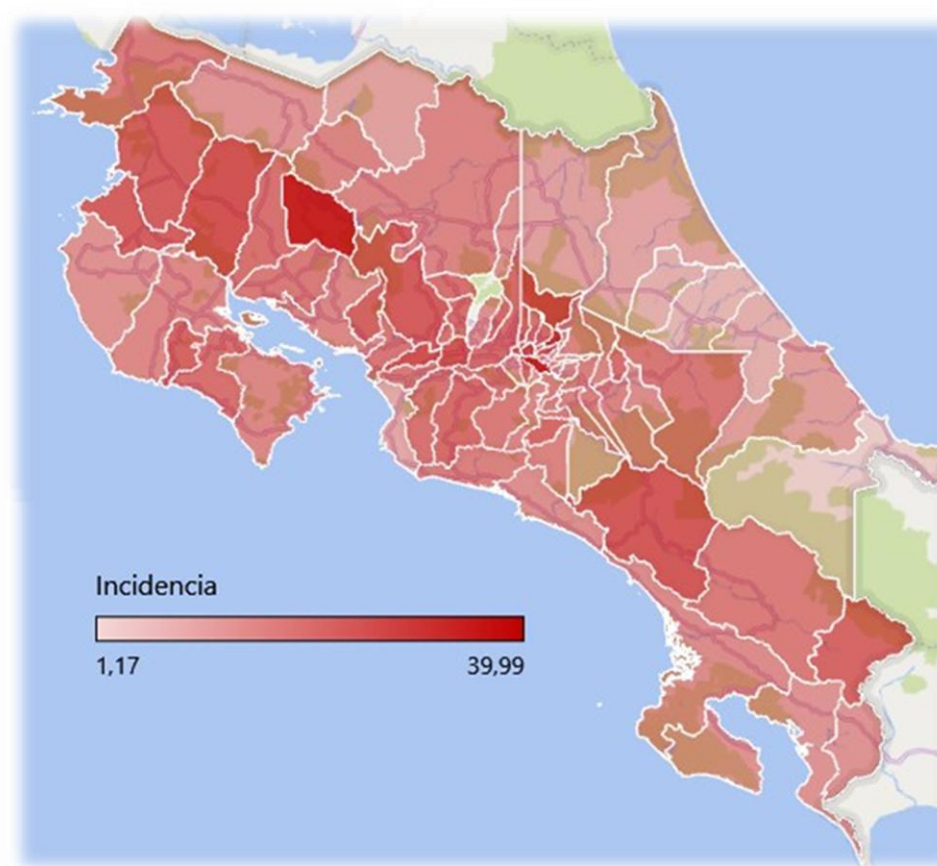
Costos Intangibles: están ocultos y son indirectos, a menudo son subestimados o ignorados, pero podría representar un mayor **costo social**.



Cáncer de Gástrico

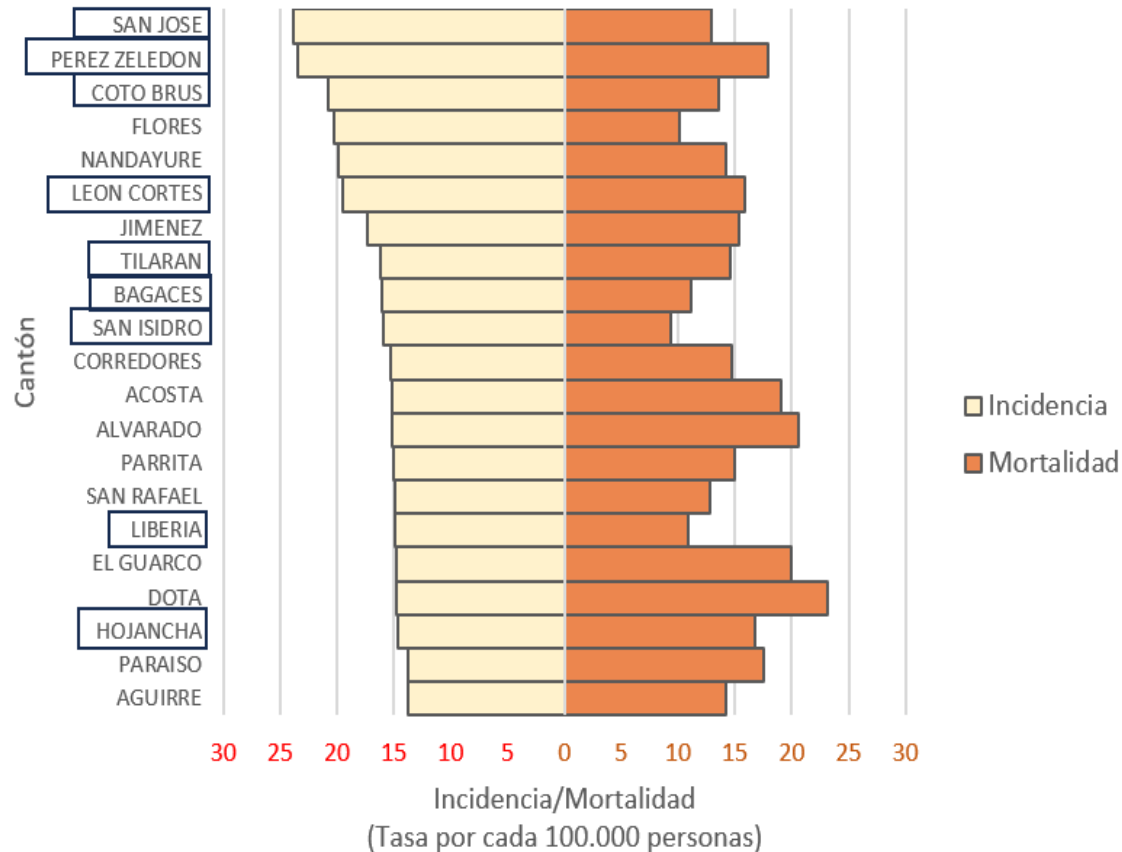


Cáncer Colorrectal

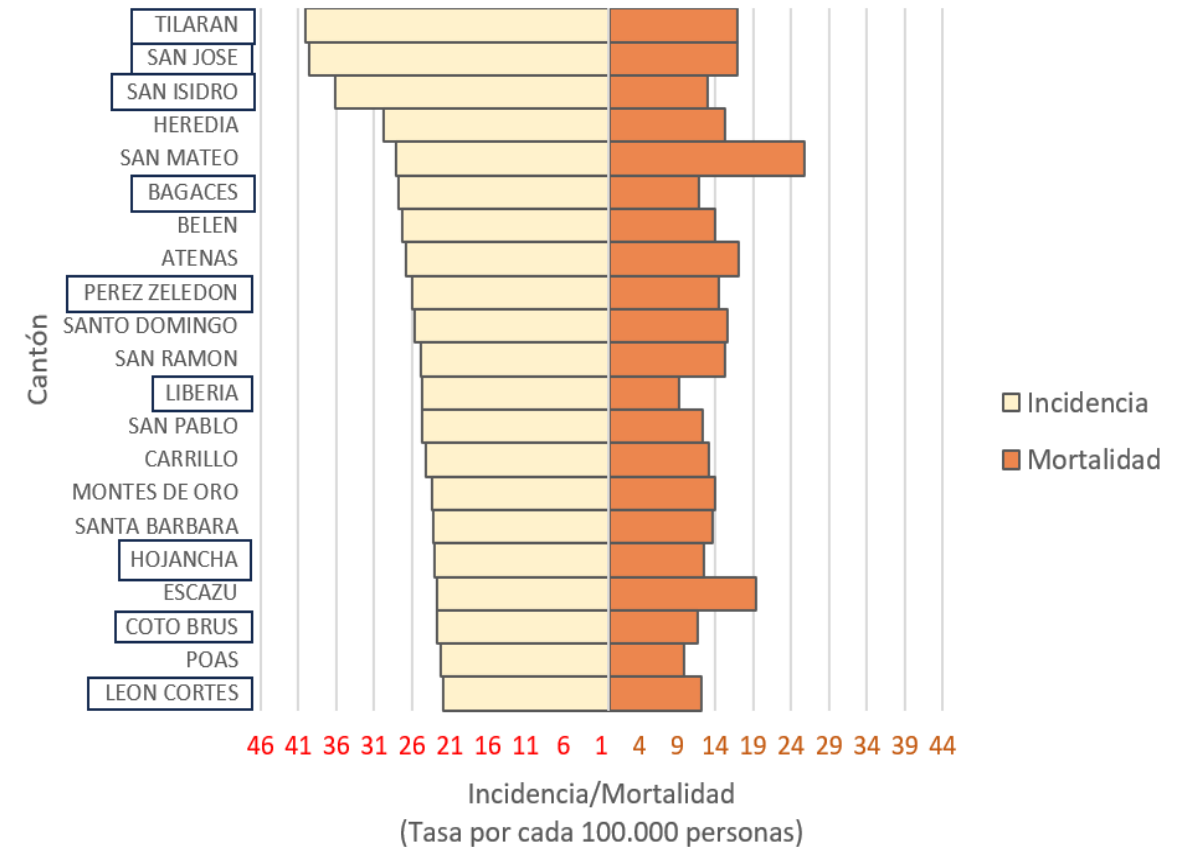


INCIDENCIA Y MORTALIDAD

Cáncer de Gástrico



Cáncer Colorrectal

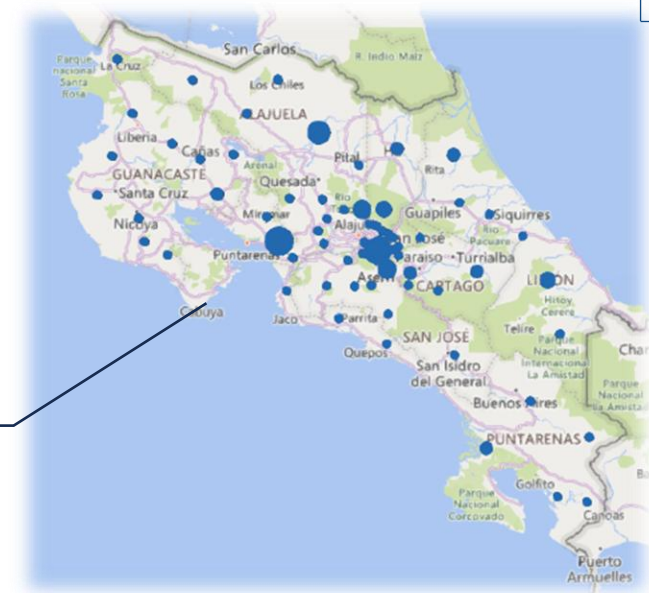


ORGANIZACIÓN FUNCIONAL EN RED

Endoscopia



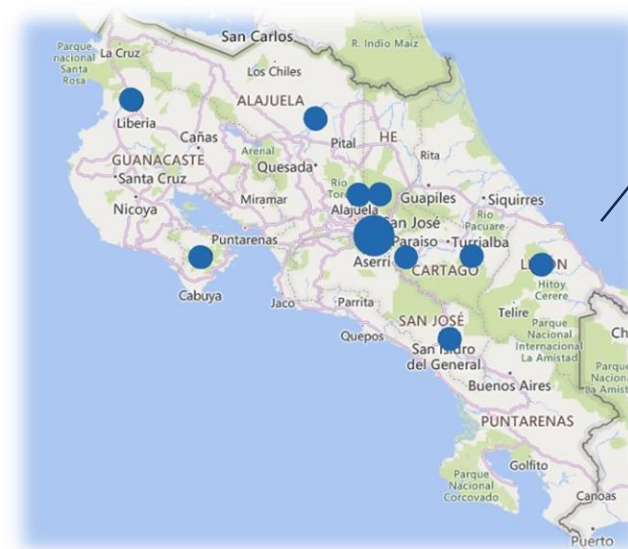
Laboratorios Clínicos



Radiología

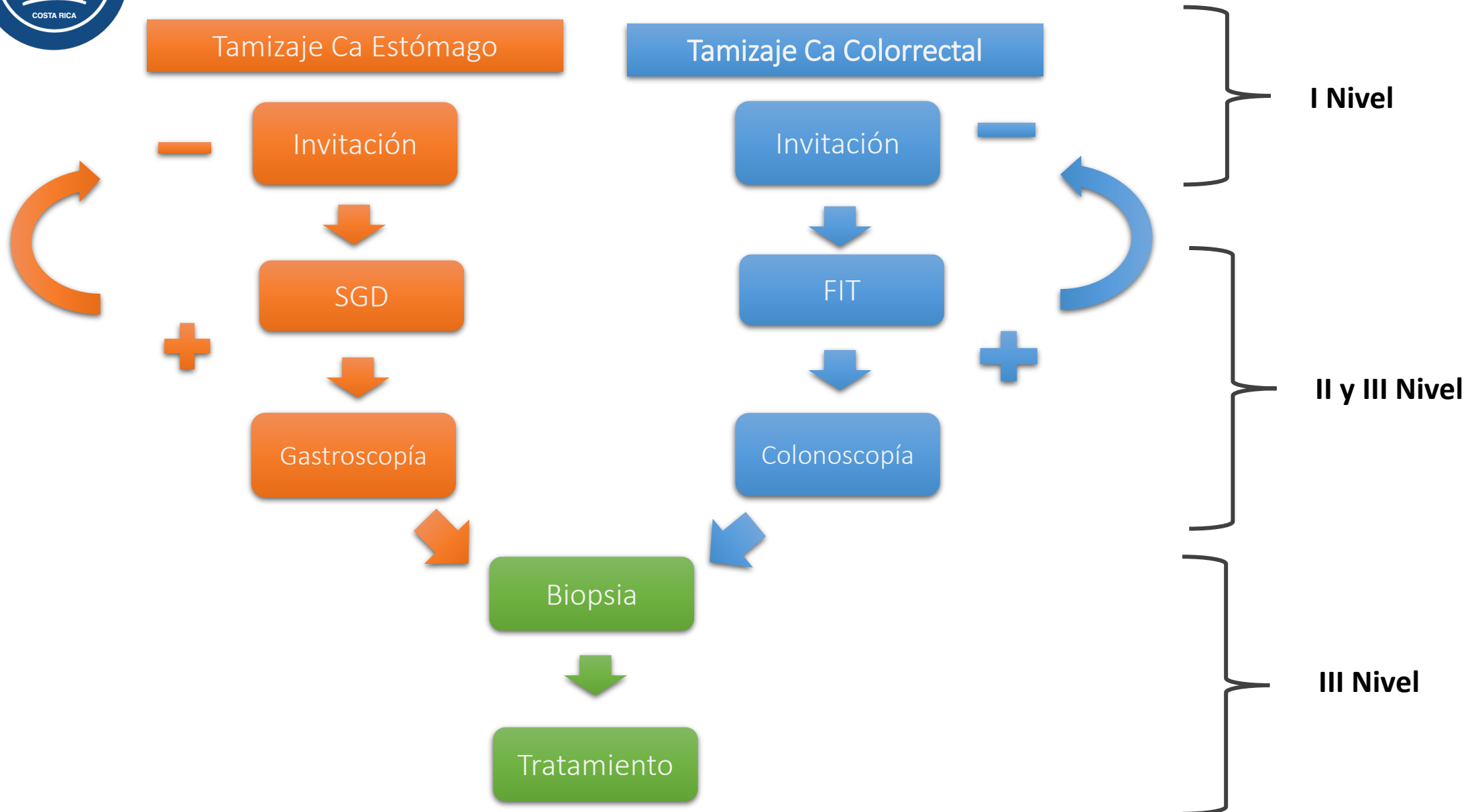


Laboratorios de Patología





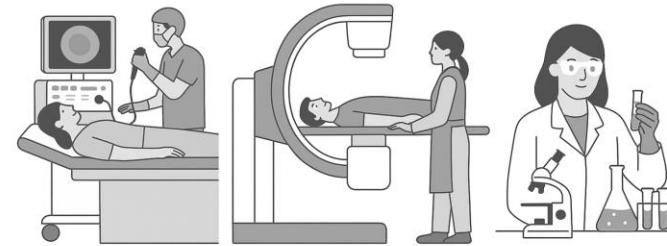
CAPTACIÓN PACIENTES



¿QUÉ SE NECESITA?



Tecnologías de Información



Endoscopía

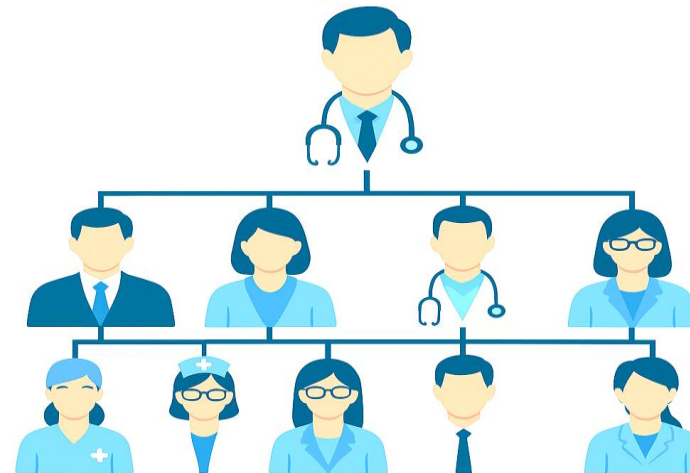
Fluoroscopia

Laboratorio
clínico



Recurso humano

Estructura organizacional robusta





FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA TIC

Generar las condiciones y ajustes necesarios para la Interoperatividad entre los diferentes sistemas:

- SIAC
- SIES
- ARCA
- SILC
- Imágenes Médicas
- SIFA

Lograr la trazabilidad permanente a los participantes.



**Tecnologías de
Información**

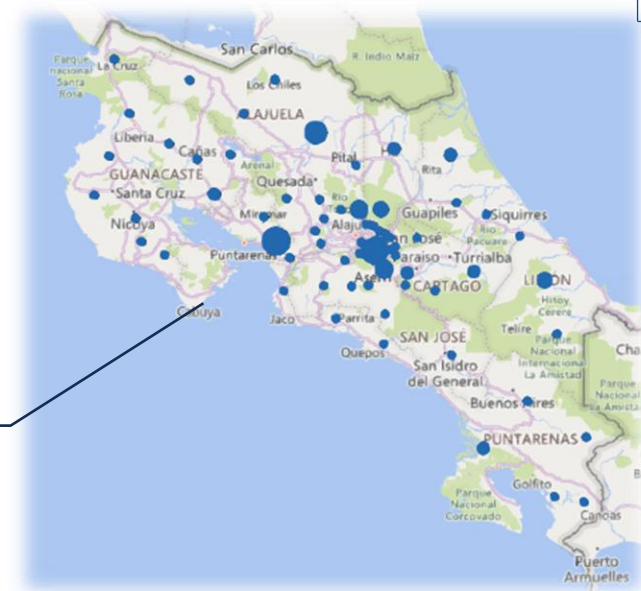


ORGANIZACIÓN FUNCIONAL EN RED

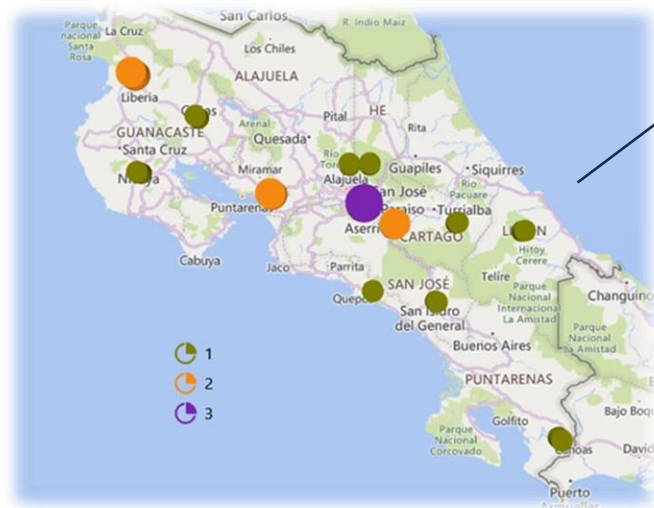
Endoscopia



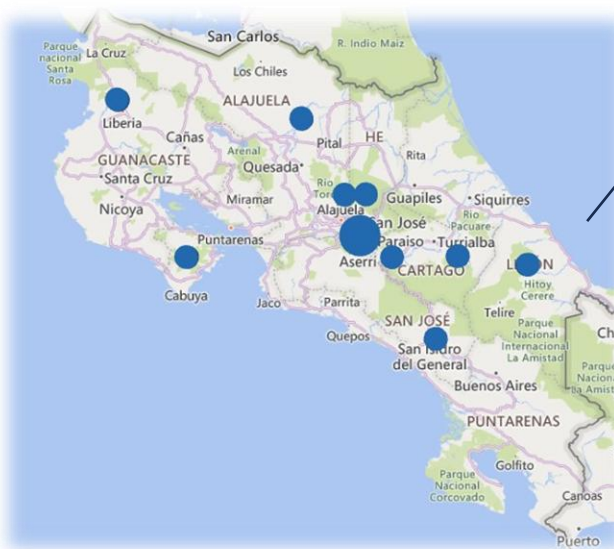
Laboratorios Clínicos



Radiología



Laboratorios de Patología



FORTALECIMIENTO EQUIPO E INFRAESTRUCTURA

Consolidación de la red de:

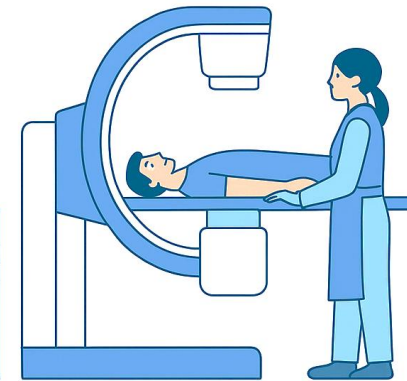
- Laboratorios Clínicos
- Salas de Endoscopía
- Salas de Fluoroscopia

Fortalecimiento de:

- Equipo
- Infraestructura



Endoscopía



Fluoroscopia



Laboratorio
clínico

Perfiles:

- Endoscopistas
- MQC
- Radiólogos
- Técnicos/Diplomados
 - Imágenes médicas
 - Endoscopia
 - Laboratorio
- Analistas de Sistemas





ESTIMACIÓN DE RECURSOS

Recurso Humano	Equipamiento e Infraestructura
Endoscopista → 12	Salas de Endoscopia → 9
Técnico de Gastroenterología → 9	Salas de fluoroscopia → 13
Médico General → 4	Equipo Móvil de Endoscopia → 1(***)
Técnico Diplomado en Imágenes → 13	
Radiólogo → 4 (*)	
Técnico de Laboratorio (**)	
Diplomado de Laboratorio (**)	
MQC3 → 1	
MQC1 → 2	
Analista de Sistemas 4 → 5	

(*) Es el equivalente a 4 radiólogos para todo el país, con acceso a las imágenes de la red de salas de fluoroscopia

(**) Dada la naturaleza de la prueba, lo que se requiere son horas de tiempo en la red de laboratorios clínicos

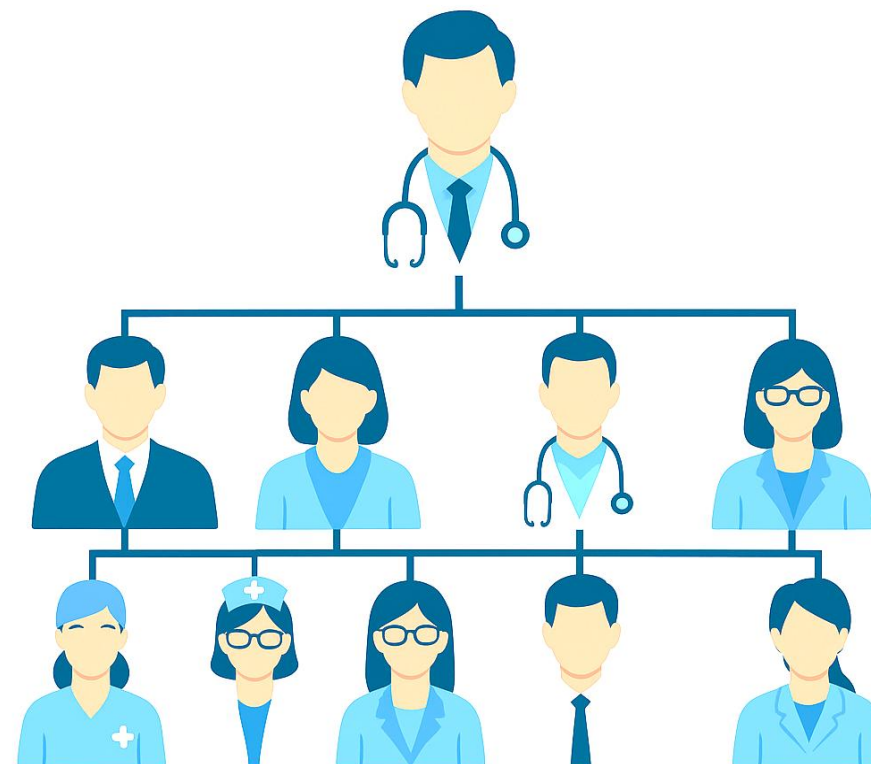
(***) Generará acceso a los estudios en los lugares en donde es difícil contar con todos los recursos necesarios

Nota: Existen otros recursos de apoyo como anestesia, enfermería y patología entre otros.



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ROBUSTA

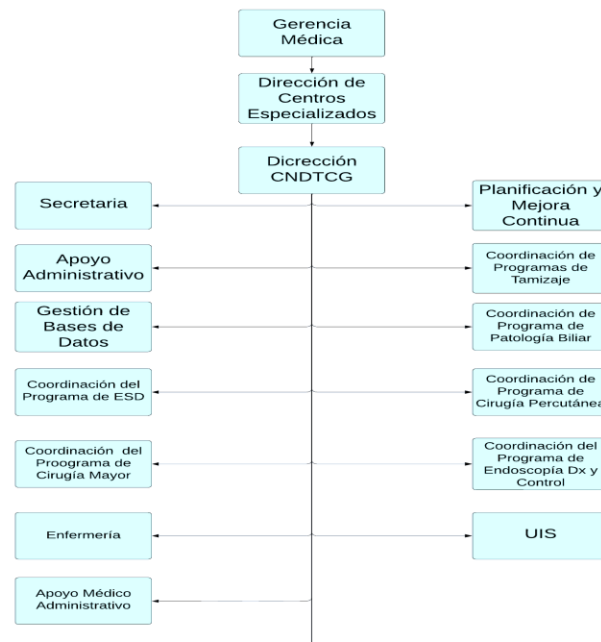
El CNDTCG al tener alcance **NACIONAL** requiere de una **estructura organizacional robusta** que responda al reto de escalar el modelo de tamizaje organizado a todo el país, para llegar a **impactar al 1.2 millones de personas** que componen la población objetivo.





HOY

CNDTCGI



Programa	Endoscopia Alta	Endoscopia Baja	Fluoroscopia	TAC	Ultrasonido	Recuperación	Consulta Externa	Sala de Operaciones
Tamizaje de Cáncer Colorrectal		Equipo Endoscopia Baja				Equipo de Recuperación		
Tamizaje de Cáncer Gástrico	Equipo Endoscopia Alta		Equipo de Fluoroscopia			Equipo de Recuperación		
Patología Biliar	Equipo Endoscopia Alta		Equipo de Fluoroscopia	Equipo de TAC		Equipo de Recuperación	Equipo de Consulta Externa	
Resección Submucosa Endoscópica (ESD)		Equipo Endoscopia Baja				Equipo de Recuperación		
Cirugía Mayor				Equipo de TAC	Equipo de Ultrasonido		Equipo de Consulta Externa	Equipo de Sala de Operaciones
Cirugía Percutánea				Equipo de TAC		Equipo de Recuperación		
Ultrasonido Endoscópico	Equipo Endoscopia Alta				Equipo de Ultrasonido	Equipo de Recuperación		
Endoscopia Diagnóstica y de Control	Equipo Endoscopia Alta	Equipo Endoscopia Baja			Equipo de Ultrasonido	Equipo de Recuperación		



NORMATIVA INSTITUCIONAL

Es necesario que la institución cuente con una normativa clara y específica que incluya directrices detalladas sobre la función, obligatoriedad y participación de cada unidad en el proceso de tamizaje.





EFECTOS DE LA FALTA DE NORMATIVA

Proyectos con inversiones de \$400.000 c/u sin resultados





ALINEAMIENTO CON EL PLANES INSTITUCIONALES

Plan Estratégico Institucional

Plan Nacional de Desarrollo

Plan Presupuesto Institucional

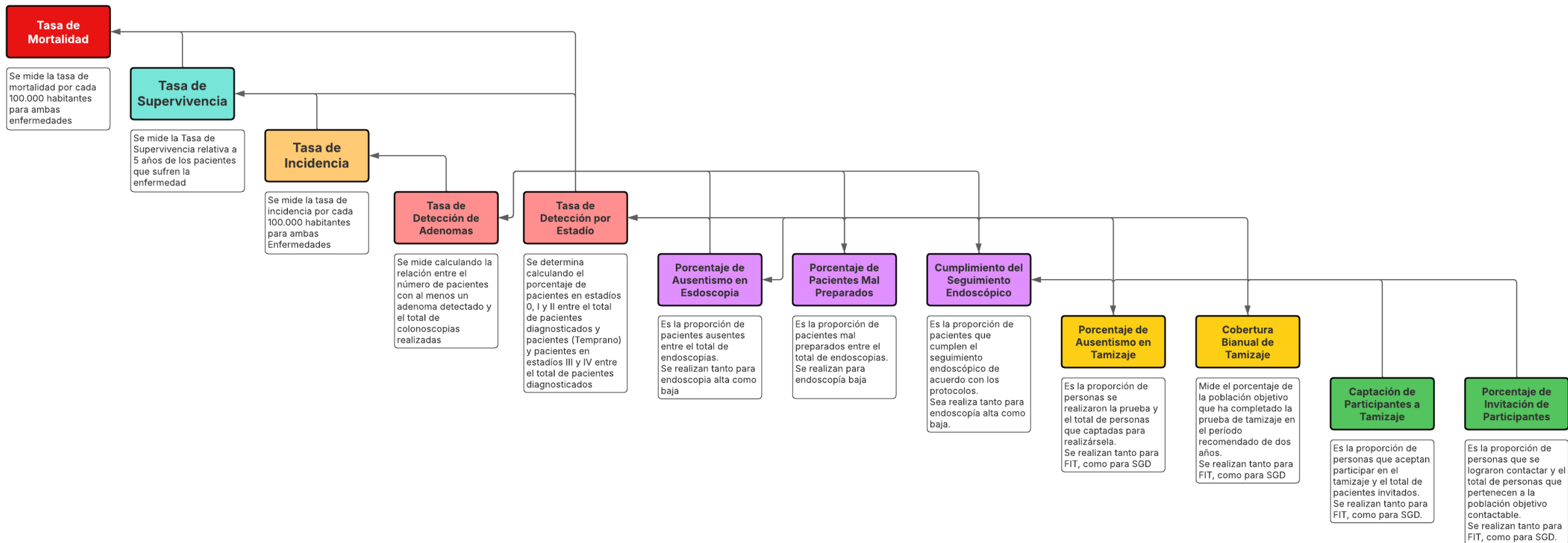
Plan Táctico Gerencial

Plan Institucional de Atención del Cáncer



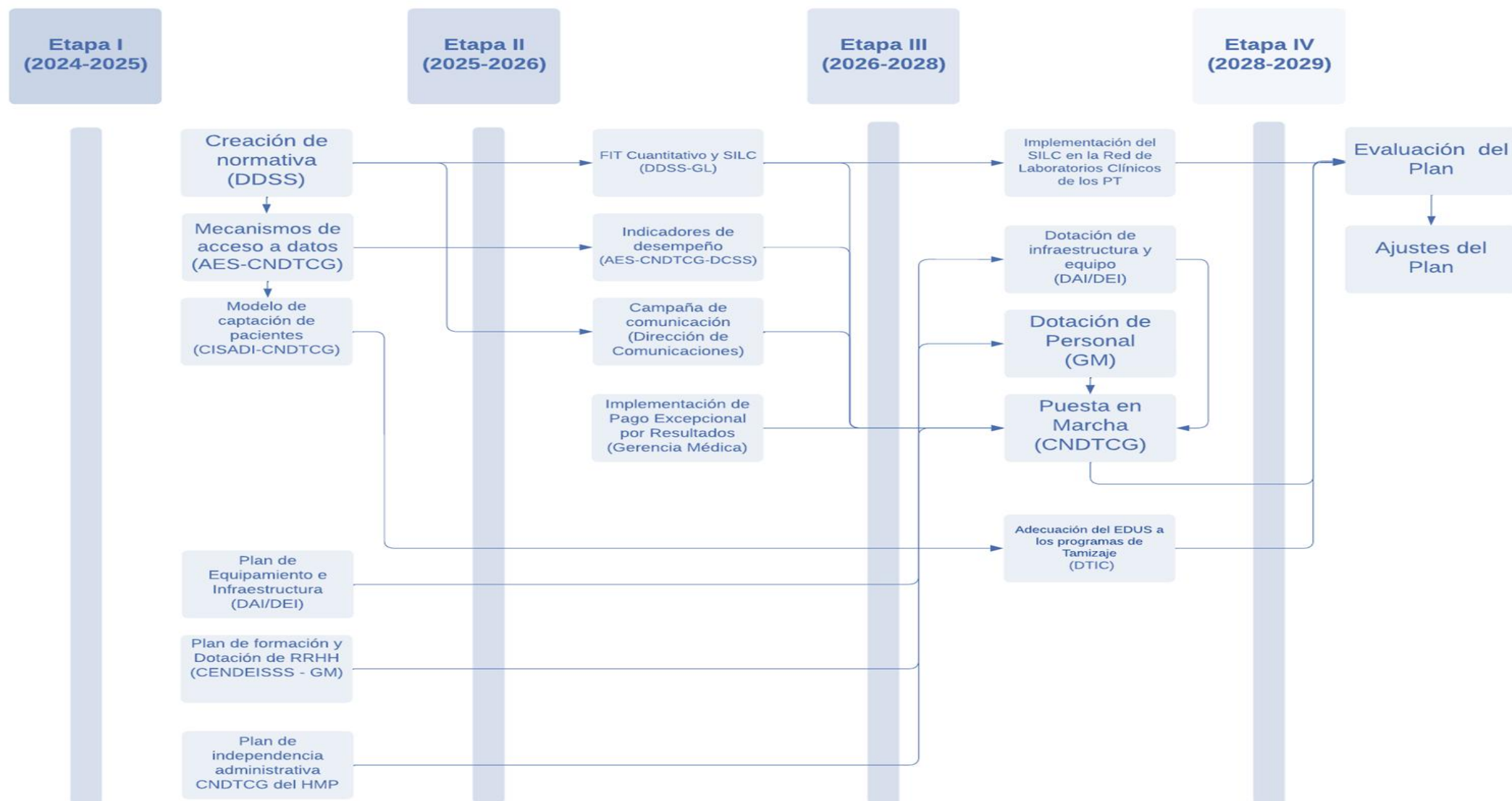


MEDICION Y CONTROL





PLAN DE ABORDAJE/FASES



CONCLUSIÓN

1

El cáncer gástrico y colorrectal presentan altas tasas de incidencia y mortalidad en Costa Rica, con una necesidad crítica de intervenciones efectivas para reducir estas cifras.

2

No existen normativas específicas que obliguen a los diferentes niveles de atención a participar en los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal, lo que dificulta la implementación uniforme y efectiva de estos programas.

3

Es fundamental que la Unidad de Investigación en Salud (UIS) en la Institución, se fortalezca y juegue un papel central en la investigación que permita la optimización de la ejecución del programa de tamizaje.



CONCLUSIÓN

4

Existen significativas desigualdades geográficas en la incidencia y mortalidad del cáncer, con ciertas provincias como San José, Cartago, Heredia y Alajuela mostrando tasas más elevadas, lo que subraya la necesidad de enfoques regionalizados.

5

La capacidad diagnóstica actual, que abarca los laboratorios clínicos, los servicios de radiología y los servicios de endoscopia, resulta insuficiente para atender la demanda proyectada, particularmente ante el crecimiento previsto de los programas de tamizaje.





PROPUESTA DE ACUERDO

Realizada la presentación por parte de la Gerencia Médica y de acuerdo con los criterios técnicos emitidos mediante oficio HMPJ-DG-CDTCG-0115-2025 y documento denominado Plan de Abordaje Integral para el Tamizaje de Cáncer de Estómago y Colorrectal (2025-2029); así como la recomendación de la Gerencia Médica realizada mediante oficio GM-18576-2025, la Junta Directiva:



ACUERDO PRIMERO

Dar por recibido y aprobado el “PLAN DE ABORDAJE INTEGRAL PARA EL TAMIZAJE DE CÁNCER DE ESTÓMAGO Y COLORRECTAL (2025-2029).”

ACUERDO SEGUNDO

Instruir a la Gerencia Médica y a la Gerencia Administrativa para que, de manera conjunta y en un plazo máximo de un mes, definan la estructura organizacional y funcional que deberá implementar el Centro Especializado de Detección Temprana de Cáncer Gastrointestinal, considerando la complejidad y el alcance de dicho centro.



PROPUESTA DE ACUERDO

ACUERDO **TERCERO**

Instruir a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación para que, en un plazo no mayor a 6 meses, desarrolle e implemente las gestiones necesarias en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) u otros aplicativos relacionados, con el fin de integrar de manera eficaz y eficiente los procesos asociados a los programas de tamizaje de cáncer gástrico y colorrectal. Estas modificaciones deberán garantizar la interoperabilidad con los sistemas de laboratorios clínicos, radiología, endoscopia y consultas especializadas, hospitalización y patología, permitiendo la trazabilidad completa del paciente desde la captación hasta el tratamiento y seguimiento postratamiento.

ACUERDO **CUARTO**

Instruir a la Gerencia de Logística para que, en un plazo no mayor a un año, realice el proceso para generar una licitación nacional de la Prueba Inmunológica Fecal.

ACUERDO **QUINTO**

Instruir a la Gerencia Médica, a la Gerencia Administrativa y a la Gerencia Financiera para que, en un plazo no mayor a 3 meses, gestionen mediante modalidad de proyectos especiales las 8 plazas requeridas para la implementación y operación del SILC, por un periodo de un año mientras se dotan por plazas ordinarias.



PROPUESTA DE ACUERDO

ACUERDO **SEXTO**

Instruir a la Gerencia Médica y a la Gerencia Administrativa para que, de manera conjunta y en un plazo máximo de 18 meses, definan la estandarización que deberán cumplir los centros especializados respecto a su estructura organizacional y funcional, con el fin de garantizar una atención oportuna a las personas, considerando la complejidad y el alcance de dichos centros.

ACUERDO **SÉPTIMO**

Instruir a la Gerencia Médica, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, y Gerencia de Logística para que, de manera articulada, realicen los análisis, definan los criterios técnicos y gestionen las contrataciones necesarias, con el fin de garantizar la operación del Centro Nacional del Cáncer una vez se efectúe el traslado del HMP a las nuevas instalaciones.



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

